



DBT

MATERIAL DE APOIO · AULA 01 DE 12

Quem somos e o que conta como evidência

Antes de aprender o modelo, o encontro combinou como se decide no que acreditar — porque é isso que separa a prática baseada em evidência da prática baseada em entusiasmo.

ENCONTRO DE SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2026 · 10H ÀS 12H
JÚLIO GONÇALVES & ANDRESSA JULIANA

DESCOMPLICANDO A DBT

Quem conduz a formação

Doze encontros ao vivo, aos sábados, para sair da leitura sobre DBT e chegar na condução da sessão — da teoria biossocial ao manejo de crise, com o pé na prática clínica.



IDEALIZADOR · PROFESSOR

Júlio Gonçalves



IDEALIZADORA · PROFESSORA

Andressa Juliana

Este material acompanha o encontro

As últimas páginas são preenchíveis: marque o checklist, responda as perguntas de revisão e guarde suas anotações no próprio arquivo. Salve depois de preencher.

O ESSENCIAL

- **A DBT está marketizada.** Circulam cursos e capítulos que pegam um pedaço do modelo, chamam de DBT e vendem. O primeiro trabalho da formação é distinguir produto de evidência.
- **Nem tudo que se lê serve.** Antes de citar um estudo, procure três coisas no método: randomização, comparador ativo e taxa de abandono.
- **A pergunta não é o diagnóstico, é o processo.** A DBT atua sobre desregulação emocional, instabilidade de identidade e déficits nas relações interpessoais.
- **Standard ou adaptada é decisão clínica.** Quanto mais severa a desregulação e mais tratamentos já falharam, mais o caso pede a DBT completa.

01 Quem conduz e por que este projeto

O *Descomplicando a DBT* nasce da mesma parceria que sustenta o *Descomplicando a TCC* há sete anos. A proposta é honrar o nome: traduzir um modelo complexo para a prática de quem atende — inclusive de quem não pretende trabalhar com DBT abrangente, mas precisa entender regulação emocional e tolerância ao mal-estar para conduzir os casos que chegam.

Andressa Juliana

Veio da TCC. Entrou na DBT por uma paciente com transtorno da personalidade borderline que tinha histórico difícil de rupturas terapêuticas — e que ela não quis encaminhar. Formação, supervisão e treinamento de habilidades vieram depois.

Júlio Gonçalves

Percurso voltado à pesquisa e à docência em psicologia clínica, com mestrado em inteligência artificial aplicada à avaliação e à intervenção. Aproximou-se das terapias contextuais e trabalha hoje com terapia baseada em processos.

Um achado que motivou o convite

Uma pesquisa sobre flexibilidade dentro da fidelidade comparou DBT, TCC e ACT. A expectativa era encontrar a ACT como a mais flexível; a DBT se mostrou mais flexível dentro dos próprios protocolos. A estrutura é fixa — mas dentro dela se modula muita coisa.

02 A DBT virou palavra de venda

Marketing é uma coisa; estrutura e evidência são outra. Existem cursos que fazem enquadres isolados — pegam habilidades, aplicam fora do contexto dos módulos e das funções — e chamam aquilo de DBT. O problema se repete na literatura: capítulos apoiados apenas em relato de caso e experiência anedótica.

O exemplo do comparador contaminado

Comentou-se em aula um estudo comparando DBT standard com terapia do esquema, com resultados equivalentes. A discussão posterior é que o protocolo de esquemas já trazia habilidades da DBT dentro. Se você compara DBT com um protocolo que contém DBT, o empate era esperado.

03 O que faz um estudo merecer confiança

Nem tudo na ciência é ensaio randomizado — na etapa de estruturação de um modelo, outros desenhos cabem. Mas depois que o modelo está estruturado, tem que haver ensaio randomizado e metanálise. Ao ler um capítulo, vá às referências do final e veja o que sustenta o texto.

- **Randomização.** Sem ela, dá para colocar os casos leves de um lado e os graves do outro. O grupo precisa ser construído por sorteio.
- **Comparador honesto.** Contra lista de espera qualquer intervenção robusta ganha: a diferença captura sobretudo a passagem do tempo.
- **Registro do protocolo.** Permite ver o que mudou no caminho — inclusive se o comparador é o que diz ser.
- **Taxa de abandono.** Quantos saíram, quando e por quê. Quem abandona altera o efeito e o desfecho.

04 A metanálise de 2019 e o que ela mostra

O estudo sintetiza ensaios controlados de DBT para comportamento suicida, olhando não só o transtorno da personalidade borderline, mas outros quadros em que esse comportamento aparece. A DBT é eficaz para o comportamento suicida tomado como espectro — que não se resume a ideação, plano e tentativa. Já sobre **ideação suicida isolada**, o efeito não se mostrou robusto.

Por psicopatologia o quadro é desigual: para transtornos alimentares as evidências apareceram muito baixas; para bipolaridade, poucos ensaios randomizados. Em casos mais severos a medicação segue como primeira linha, com a TCC mantendo posição de primeira linha em vários quadros.

CUIDADO COM A LEITURA DE "EVIDÊNCIA BAIXA"

Baixa nem sempre significa que o tratamento é ruim: muitas vezes significa que faltam estudos concorrentes. Mas, comparado ao que existe hoje, é preciso ser justo e dizer que é baixo.

05 Por que processos explicam os buracos da evidência

Se a evidência é escassa em substâncias, bipolaridade e transtornos alimentares, uma hipótese é que os estudos mirem no diagnóstico e não no processo. Um paciente bipolar cujas demandas são relacionais tende a responder melhor à DBT; outro, cuja depressão é de desesperança sobre projeto de vida, tende a responder melhor à TCC. Mesmo diagnóstico, processos diferentes.

Por que funcionou com adolescentes

Todo adolescente atravessa uma fase de instabilidade de identidade. No borderline, essa instabilidade é crônica. O modelo talvez tenha alcançado adolescentes por trabalhar justamente o processo transdiagnóstico da identidade e das relações interpessoais.

Existe ainda a vertente voltada aos **super-regulados** — anorexia e perfil obsessivo-compulsivo —, enquanto a DBT padrão trabalha com os **sub-regulados**: outra evidência de que a lógica é processual, não diagnóstica.

06 De onde o modelo veio

Marsha Linehan desenhou o protocolo para mulheres com comportamento suicida grave e autolesão. O enquadramento no diagnóstico de borderline veio depois: numa reunião com a agência norte-americana que financia pesquisa, uma avaliadora apontou que o tratamento descrito era para pessoas com esse diagnóstico. Estudando depois, ela foi encontrando mulheres que de fato fechavam critérios.

O primeiro ensaio saiu em 1991; em 2015 o método foi replicado com outra amostra. O aprimoramento veio de vários lados: Martin Bohus, na Alemanha, desenvolveu uma

vertente para TEPT complexo a partir de uma população internada, sobretudo mulheres com histórico de abuso sexual na infância.

A visão que sustenta tudo

Para Linehan, o comportamento suicida é uma tentativa mal adaptativa de resolver um problema. A tarefa da terapia é ajudar a pessoa a resolver seus problemas e a construir uma vida que faça sentido — para que a ideiação deixe de ser necessária.

07 Do pensamento ao ato: onde cada modelo atua

Na matriz da terapia baseada em processos, a DBT atua predominantemente no domínio **biofisiológico** — o da desregulação. Por isso vai bem sobre autolesão e tentativa, que são atos observáveis. Quando o problema está mais na cognição — ideiação passiva, ativa, plano — o padrão-ouro é a TCC para suicídio. Muitos pacientes ficam no meio, e aí se usam elementos dos dois modelos.

AS DEFINIÇÕES SÃO BORRADAS — E ISSO É CLÍNICO

Beber até ficar dopado é tentativa ou anestesia da dor emocional? Muitas vezes é um self de morte que não se escancara e aparece por substância ou prática sexual insegura. O que importa é identificar a função do comportamento — e lembrar que esses sinais podem estar escalonando.

08 Habilidades não são plano de ação

Habilidade jogada ao vento não é DBT. Sem hierarquia de alvos, objetivos construídos, avaliação das situações da semana e análise em cadeia — discutida com o time de consultoria — o que se faz é apagar incêndio. E terapia que apaga incêndio sem atacar o núcleo vê o problema voltar.

Antes da técnica vem a motivação, que não brota de dentro: o termo vem de *ter motivos*. A premissa de que o paciente está fazendo o melhor que pode não pode virar paralisação — ele está fazendo o melhor que pode e pode dar mais meio por cento.

09 Standard ou adaptada

- Há desregulação emocional intensa e persistente?
- Há comportamentos que ameaçam a vida ou o andamento da terapia?

- Há múltiplos problemas simultâneos — projeto de vida, trabalho, família, relações?
- Já houve tratamentos que não funcionaram, inclusive bem estabelecidos?
- Há déficits generalizados nas relações interpessoais, por self e identidade instáveis?

A prática adaptada — princípios e habilidades da DBT dentro de outro enquadre — é legítima. O que não é legítimo é chamá-la de DBT completa.

10 Referências

- DeCou, C. R., Comtois, K. A., & Landes, S. J. (2019). Dialectical behavior therapy is effective for the treatment of suicidal behavior: A meta-analysis. *Behavior Therapy*, 50(1), 60–72.
- Linehan, M. M., Armstrong, H. E., Suarez, A., Allmon, D., & Heard, H. L. (1991). Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. *Archives of General Psychiatry*, 48(12), 1060–1064.
- Linehan, M. M., Korslund, K. E., Harned, M. S., et al. (2015). Dialectical behavior therapy for high suicide risk in individuals with borderline personality disorder: A randomized clinical trial and component analysis. *JAMA Psychiatry*, 72(5), 475–482.
- Bohus, M., Kleindienst, N., Hahn, C., et al. (2020). DBT-PTSD compared with cognitive processing therapy in complex presentations of PTSD in women survivors of childhood abuse. *JAMA Psychiatry*, 77(12), 1235–1245.

NOTA DE MÉTODO

Resumo fiel à transcrição do encontro. Três ajustes de precisão ficam registrados: a metanálise de 2019 foi descrita em aula como reunindo dezoito revisões sistemáticas — na fonte original ela agrega dezoito ensaios controlados, e a estimativa de milhares de estudos derivada dessa leitura não se sustenta; a sigla da agência norte-americana de financiamento não foi precisada em sala; e o desenvolvimento da vertente para TEPT nos Estados Unidos foi mantido em termos gerais, por não ter sido possível confirmar a população descrita. O estudo comparando DBT e terapia do esquema foi citado de memória e não conferido — permanece como relato de discussão, sem referência. Falas de participantes foram mantidas de forma genérica, sem identificação.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão. O arquivo guarda o que você preencher.

Procurei um artigo sobre DBT numa base de dados e conferi randomização, comparador e abandono.

Escolhi um paciente para acompanhar ao longo das 12 aulas, levando o conteúdo para a semana.

Apliquei as cinco perguntas de severidade e cheguei a uma posição: standard ou adaptada.

Identifiquei qual processo — e não qual diagnóstico — pretendo alcançar nesse caso.

Revisei se alguma habilidade que ensino está solta, sem modo, estágio e função definidos.

Minhas anotações — o que levo para a clínica

Para revisar — responda

Responda com suas palavras. O texto fica salvo no PDF.

01. Por que comparar uma intervenção com lista de espera infla o resultado? O que muda quando o comparador é uma abordagem ativa?
02. A metanálise mostrou efeito sobre o comportamento suicida, mas não sobre a ideação isolada. Como a lógica de processos ajuda a explicar essa diferença?
03. Dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem pedir modelos diferentes. Descreva um caso seu em que o processo definiria a conduta.
04. O que diferencia ensinar habilidades de fazer DBT? O que precisa estar montado antes da técnica?